

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

التخدير
إقرار المريض

Anesthesia Patient Consent

This is to provide you and your family with information on some of the possible risks of having anesthesia.

1. Anesthesia is needed to relieve you of pain and stress during surgical procedures. However, all forms of anesthesia involve some risks even death. The perioperative mortality (reported death rate during operation) correlates with a patient's preoperative health conditions. The predicted perioperative mortality rate listed below is based on a five-category physical status classification system adopted by the American Society of Anesthesiologists.

Class1: normal healthy patient (death rate 0.06-0.08%)

Class2: mild systemic disease and no functional limitations (death rate 0.27-0.4%)

Class3: moderate to severe systemic disease that results in some functional limitations (death rate 1.8-4.3%)

Class4: severe systemic disease that is a constant threat to life and functionally incapacitating (death rate 7.8-23%)

Class5: not expected to survive 24 h with or without surgery (death rate 9.4-51%)

2. As with any other medical intervention (any measure whose purpose is to improve health or alter the course of disease) there are risks of potential complications with virtually all forms of anesthesia.

2.1. Existing or past medical problems may add risk during and after surgery.

2.1.1 Cardiovascular problems such as chest pain, a previous heart attack, heart failure, high blood pressure or valvular heart disease increase your risk of heart attack and stroke.

2.1.2 Lung problems such as asthma, respiratory tract infection, or chronic obstructive lung diseases may worsen your lung condition after surgery.

2.1.3 Other conditions such as liver disease, kidney problems, hormonal disorders, cancer, alcohol, or drug abuse also increase your risk.

2.2. During anesthesia, we must keep your airway open. This can result in injury to your teeth, dental work, tongue, lips, nose or throat. You may have a sore throat from the airway used during surgery.

2.3 You may vomit the contents of your stomach during surgery. They may enter the lungs and cause breathing problems. This risk of inhalation of stomach content will greatly increase in an emergency surgery or in a patient

تقدم هذه الوثيقة لكم وأسرناكم معلومات عن بعض المخاطر المحتملة للتخدير الذي سيجري لكم.

1. ثمة ضرورة لإجراء التخدير لتخفيف وتسكين ألم العمليات والإجراءات الجراحية، ومهما يكن من أمر، فإن كل أنواع التخدير تنطوي على بعض المخاطر ومن ضمنها الوفاة. وهناك علاقة بين معدل الوفاة التي تحدث حول العملية (معدل الوفيات المبلغ عنها خلال العمليات الجراحية) وأحوال المريض الصحية حول العملية. إن معدل الوفيات المتنبئ عنها والموضحة أدناه مبنية على أساس نظام تصنيف الوضع البدني للفئات الخمسة أدناه والتي تبينها الجمعية الأمريكية لأخصائيي التخدير:

الفئة (1): مريض ذو صحة عادية (معدل الوفيات 0,08-0,06%).

الفئة (2): مرض شامل معتدل مع عدم وجود قصور وظيفي (معدل الوفيات 0,27-0,4%).

الفئة (3): مرض شامل معتدل-شديد مع بعض القصور الوظيفي (1,8-4,3%).

الفئة (4): مرض شامل شديد يشكل خطر دائم على الحياة مع عجز وظيفي (معدل الوفيات 7,8-23%).

الفئة (5): مريض غير متوقع بقاءهم على قيد الحياة 24 ساعة بعملية جراحية أو بدونها (معدل الوفيات 9,4-51%).

2. ثمة مخاطر تنطوي على مضاعفات محتملة واقعية لجميع أنواع التخدير كما هو الحال في أية تدخلات طبية أخرى (أي إجراء الغرض منه تحسين الصحة أو تغيير مسار المرض).

2.1 قد تؤدي المشاكل الطبية الحالية أو السابقة إلى مخاطر أخرى خلال وبعد الجراحة.

2.1.1 منها مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل ألم الصدر أو نوبة قلبية سابقة أو فشل القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تفاقم مرض القلب الصمامي الذي يؤدي إلى زيادة النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

2.1.2 مشاكل الرئة مثل الربو والتهاب المسالك التنفسية أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو قد تؤدي إلى تفاقم حالة الرئة بعد الجراحة.

2.1.3 حالات أخرى مثل مرض الكبد أو مشاكل الكلى أو الاضطرابات الهرمونية أو السرطان أو الكحول أو سوء استخدام العقاقير والتي تؤدي أيضاً إلى تفاقم مخاطرك.

2.2 يجب الإبقاء على مجرى التنفس لديك مفتوحاً خلال الجراحة مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بأسنانك أو أعمال معالجة الأسنان أو اللسان أو الشفتين أو الأنف أو الحلق. وقد تصاب بالتهاب الحلق من خلال استخدام

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- with increased abdominal (muscle of the abdomen) pressure. (intestinal obstruction, pregnancy).
- 2.4 You may have complications to drugs or blood products you receive during surgery. On rare occasions, these may be life-threatening
- 2.5 You may sometimes have skin or nerve injury from positioning required for surgery or equipment used during surgery.
- 2.6 You may have a headache or backache after a spinal or epidural anesthesia (blocking the sensation and movement of the lower half of the body). On rare occasions, transient neurological (mild numbness) symptoms or even permanent nerve damage can occur.
- 2.7 Some drugs given during surgery may cause your muscles to be sore and stiff.
- 2.8 Although rarely occurs, an incidence of 0.2% is reported for the occurrence of awareness during general anesthesia. Most of these cases are reported by patients undergoing major cardiothoracic (heart-lung) surgeries.
- 2.9 Although rarely, malignant hyperthermia (unexplained sudden rise of temperature) may occur in genetically susceptible (increase chance of having a particular disease due to a family history that indicates an increased risk of the disease) patients after in contact with an anesthetic triggering agent (1:15,000 in pediatric patients and 1:40,000 in adult patients).
- 2.10 While waking up from anesthesia, some patients may shake or shiver.
- 2.11. Some patients feel nauseated or vomit after surgery or anesthesia. This can be influenced by a history of motion sickness, the type of surgery performed, anesthetics used during surgery, and the pain medications after surgery.
3. In the event of a sudden unexpected critical condition (injury to the brain due to lack of oxygen supply or massive bleeding), extraordinary measures (surgical opening of the wind pipe to secure the airway or arterial and central venous catheter insertion which is done by introducing small tube into the blood vessels to stabilize the vital signs i.e. blood pressure, heart rate, oxygen saturation) may become necessary.

مجرى الهواء أثناء الجراحة.

2.3 خلال الجراحة ربما تتقيأ ما تناولته من أكل وشراب وقد يدخل في رئتيك مسبباً لك مشاكل في التنفس. و سيقام استنشاق هذا الأكل والشراب كثيراً في حالة الجراحة الطارئة أو في حالات المرضى الذين يعانون من ازدياد الضغط البطني (ضغط عضلات الأمعاء) (الانسداد المعوي أو الحمل).

2.4 قد تتعرض لمضاعفات بسبب الأدوية ومشتقات الدم التي تتلقاها خلال الجراحة. وفي حالات نادرة قد تشكل هذه المضاعفات تهديد للحياة.

2.5 قد تتعرض في بعض الأحيان لإصابة في الجلد أو العصب ناتجة عن الوضعية المطلوبة لإجراء الجراحة أو الأجهزة المستخدمة خلال الجراحة.

2.6 ربما تصاب بصداع أو ألم بالظهر بعد إجراء تخدير شوكي أو تخدير فوق الجافية (حصر الاحساس وحركة الطرف السفلي للجسم). وقد تحدث في حالات نادرة أعراض عصبية عابرة (خدر معتدل) أو حتى ضرر أو تلف عصبي دائم.

2.7 قد تسبب بعض الأدوية التي تعطي لك خلال الجراحة ألم وتيبس في العضلات.

2.8 رغم أنه من النادر استعادة الوعي خلال التخدير العام إلا أن هناك تقارير تفيد حدوث ذلك في 0.2% من الحالات وحدثت معظم تلك الحالات لمرضى خضعوا لعمليات جراحية قلبية صدرية (قلبية – رئوية).

2.9 قد يحدث أحياناً في حالات نادرة (ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة مجهول السبب) لدى المرضى الذين لديهم استعداد وراثي (ازدياد احتمالات التعرض لمرض محدد نتيجة للتاريخ العائلي الذي يشير إلى زيادة احتمالات المرض) عقب ملامسة أداة محفزة للتخدير (1:15,000 لدى الأطفال المرضى و 1:40,000 لدى المرضى الكبار).

2.10 قد تحدث بعض المضاعفات بعد الإفاقة من التخدير مثل (الرجفة أو التمايل أثناء المشي).

2.11 ربما يشعر بعض المرضى بميل للغثيان أو التقيؤ بعد الجراحة أو التخدير خاصة لدى المرضى ممن لديهم تاريخ إصابة بدوار الحركة أو نوع الجراحة التي أجريت لهم أو المادة المخدرة المستخدمة أثناء الجراحة والمسكنات المستعملة بعد الجراحة.

3. قد تحدث أعراض مفاجئة غير متوقعة وخطيرة وفي هذه الحالات يتم اتخاذ إجراءات استثنائية مثل (فتح القصبة الهوائية أو مجرى التنفس جراحياً لتأمين مجرى الهواء أو تركيب قسطرة بالوريد المركزي بإدخال أنبوب صغير بالأوعية الدموية لضمان استقرار العلامات الحيوية مثل ضغط الدم ومعدل التنفس وتثبيع الأوكسجين في الدم).

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

• **4-Table. 1 Types of Anesthesia with Risks and Benefits**

General Anesthesia التخدير العام	Expected Result النتيجة المتوقعة	Total unconscious state, possible placement of a tube into the windpipe حالة فقدان تام للوعي مع احتمال تركيب أمبوبة تنفس بالقصبة الهوائية.
	Technique طريقة التخدير	Drug injected into the bloodstream, breathed into the lungs, or administered by other routes حقن الدواء المخدر في الدورة الدموية أو يتم استنشاق أنواع أخرى داخل الرئتين أو إعطائه بأساليب أخرى.
	Risks المخاطر	Mouth or throat pain, hoarseness, injury to mouth or teeth, momentary awareness under anesthesia, injury to blood vessels, inhalation of stomach content, pneumonia ألم بالفم أو الحلق أو بحة في الصوت أو إصابة الفم والأسنان أو إسترجاع مؤقت للوعي مع التخدير أو تضرر أوعية دموية أو استنشاق محتويات المعدة أو التهاب رئوي.
Spinal or Epidural Analgesia/Anesthesia (blocking the sensation and movement of the lower half of the body)With sedation/Without sedation تخدير شوكي وتخدير فوق الجافية وتسكين أو تخدير (باحصار الاحساس وحركة النصف السفلي) مع أو بدون تسكين.	Expected Result النتيجة المتوقعة	Temporary decrease or loss of feeling and/or movement to lower part of body انخفاض مؤقت أو فقدان للحس وحركة الجزء السفلي من الجسم
	Technique طريقة التخدير	Drug injected through a needle/catheter placed either directly into the spinal canal or immediately outside the spinal canal يحقن الدواء المخدر بإبرة أو قسطرة يتم إدخالها إما داخل القناة الشوكية(السائل المحتط بالعصاب) أو خارجها مباشرة.
	Risks المخاطر	Headache, backache, buzzing in the ears, convulsions, infection, persistent weakness, numbness, residual pain, injury to blood vessels صداع أو ألم ظهر أو طنين في الأذنين أو تشنجات أو التهاب أو ضعف مستمر أو تنميل أو ألم متبقي أو تلف أوعية دموية.
Major / Minor Nerve Block With sedation/Without sedation احصار عصبي رئيسي / ثانوي مع أو بدون تسكين	Expected Result النتيجة المتوقعة	Temporary loss of feeling and/or movement of a specific limb or area of the body فقدان مؤقت للإحساس أو عدم حركة طرف محدد أو منطقة بالجسم
	Technique طريقة التخدير	Drug injected near nerves providing loss of sensation to the area of the operation حقن الدواء المخدر جوار الأعصاب الطرفية لغرض فقدان الحس بموضع العملية
	Risks المخاطر	Infection, convulsions, weakness, continuous numbness, residual pain, injury to blood vessels التهاب أو تشنجات أو ضعف أو تنميل مستمر أو ألم متبقي أو تلف أوعية دموية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Intravenous Regional Anesthesia (drug injected into the veins of arm or leg) With sedation/Without sedation تخدير ناحي (حقن) الدواء المخدر داخل أوردة الذراع أو الساق مع أو بدون تسكين	Expected Result النتيجة المتوقعة	Temporary loss of feeling and/or movement of a limb فقدان مؤقت للإحساس و / أو حركة طرف بالجسم
	Technique طريقة التخدير	Drug injected into veins of arm or leg while using a tourniquet (a constricting or compressing device, specifically a bandage, used to control <u>venous</u> and <u>arterial</u> circulation to an extremity for a period of time.) حقن الدواء المخدر داخل أوردة الذراع أو الساق باستعمال عاصبة (رباط للتحكم في سريان الدم في الوريد أو الشريان لبعض الوقت)
	Risks المخاطر	Infection, convulsions, persistent numbness, residual pain, injury to blood vessels التهاب أو تشنجات أو تدمير مستمر ألم متبقي
Monitored Anesthesia Care رعاية تخديرية مراقبة	Expected Result النتيجة المتوقعة	Reduced anxiety and pain, partial or total amnesia قلق أو ألم بسيط أو فقدان جزئي أو كلي للذاكرة
	Technique طريقة التخدير	Drug injected into the bloodstream, breathed into the lungs, or administered by other routes حقن الدواء داخل الدورة الدموية أو يتم استنشاق غازات التخدير داخل الرئتين أو إعطائه بأساليب أخرى
	Risks المخاطر	An unconscious state, depressed breathing, injury to blood vessels حالة فقدان للوعي أو تنفس منخفض أو إصابة الأوعية الدموية
Moderate Sedation تهدئة متوسطة		Reduced anxiety and pain, enhance the tolerance to procedure, partial amnesia التهدئة و تقليل الألم و مساعدة المريض علي تحمل و عدم التذكر العملية
	Technique طريقة التخدير	Drug injected into the bloodstream حقن الدواء في الدم
	Risks المخاطر	An unconscious state, depressed breathing, injury to blood vessels حالة فقدان للوعي أو تنفس منخفض أو إصابة الأوعية الدموية

حقن

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patient Consent:

- I consent that the anesthesia doctor explained to me all the necessary information regarding the Anesthesia, also discussed with me all the alternatives and answered all my questions and concerns satisfactorily.
- I consent that the anesthesia doctor discussed with me all the possible risks and complications that are related to anesthesia.
- I received a copy of this document to read it and keep it for my own records.
- I consent to give a sample of my blood for screening of infectious diseases (such as, HIV and hepatitis) in case the anesthesia doctor or hospital staff faces an accidental needle prick that is contaminated with my own blood.

Patient Name: _____

Patient Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Anesthesiologist Consent:

- I have discussed all the options of anesthesia, and explained all the benefits and risks related to anesthesia and all the possible complications that can occur.
- I have given the chance to the patient to ask any questions related to anesthesia and I have answered all her question.

Doctor Name: _____

Doctor Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

إقرار المريضة:

- أقر بأن أخصائي التخدير قد زودني بالمعلومات اللازمة عن التخدير، و الطرق البديلة للتخدير، و أجاب على كافة استفساراتي و مخاوفي المعينة الخاصة بهذا الموضوع.
- أقر بأنني قد ناقشت مع أخصائي التخدير أي المخاطر و المضاعفات هامة تتعلق بحالتي و ظروفي الشخصية، و أنني قد أخذتهم في الاعتبار عندما قررت التخدير.
- أقر بأنني استلمت نسخة من هذا التقرير لقراءة و الاحتفاظ به في سجلاتي
- أقر بأنني اسمح للمستشفى بأخذ عينة من دمي لفحص الامراض المعدية (مثل التهاب الكبد ومرض نقص المناعة المكتسب) في حال تعرض طبيب التخدير او احد الطاقم الطبي لوخز إبرة استعملت اثناء عملية التخدير

إسم المريضة: _____

توقيع المريضة: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

إقرار طبيب التخدير

- أقر بأنني قد قمت بتوضيح طبيعة التخدير الذي سيتم استخدامه و ما قد يترتب عليه من نتائج ، فضلاً عن مناقشة المخاطر التي تثير مخاوف المريض.
- وقد أتحت للمريض فرصة الإستفسار عن كل ما يتعلق بهذا الأمر و أجبت عن كافة استفساراته و تساؤلاته.

اسم الطبيب: _____

توقيع الطبيب: _____

التاريخ: _____ الوقت: _____

توقيع الشهود :

1) الإسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

2) الإسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____